



GUIA PARA PACIENTES

Torci o tornozelo: as 2 primeiras semanas

o que fazer, o que evitar e quando procurar o médico

Como cuidar da entorse nos primeiros dias, quais sinais pedem raio-X e por que o treino de equilíbrio ajuda a evitar a próxima torção.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **TORNOZELO**

Para quem é:

Para adultos que **torceram o tornozelo** (o pé "virou") há poucos dias e **não têm nenhum sinal de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Crianças e adolescentes em fase de crescimento: a avaliação é diferente e deve ser feita por um médico.
- Quem já torceu o mesmo tornozelo várias vezes ou sente que ele "falseia": leia a Página 9 e procure avaliação.
- Quem tem diabetes com perda de sensibilidade nos pés, usa remédio para "afinar o sangue" ou operou o tornozelo: converse com seu médico antes.

O que você vai precisar:

- Dois travesseiros, para elevar o pé.
- Uma faixa elástica ou bandagem de compressão.
- Uma bancada ou cadeira firme, para se apoiar nos exercícios.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Apoiar o pé e se mexer **dentro do que a dor permite**: sim.

Dor que **aumenta muito** ou tornozelo **mais inchado no dia seguinte**: reduza.

Algum sinal da Página 3: **pare e procure atendimento.**

A maioria das entorses não quebra osso. Mas algumas situações não podem esperar. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se:

- Há **ferida aberta** no local da lesão, ou **osso aparecendo**.
- O tornozelo ou o pé ficou **torto**, com formato diferente do outro lado.
- O pé está **frio, pálido ou arroxeadado**, ou há **dormência** ou formigamento que não passa.
- A dor é **muito forte e só aumenta**, mesmo em repouso e com o pé elevado.

Esses sinais podem indicar fratura, luxação ou sofrimento de vasos e nervos.

Precisa de raio-X? As Regras de Tornozelo de Ottawa

Os médicos usam essas regras para decidir quem precisa de radiografia [1] [2]. Procure avaliação se:

- Você **não consegue dar 4 passos** apoiando o pé, nem mancando, logo depois da torção ou na hora do atendimento.
- Dói **ao apertar o osso** na borda de trás ou na ponta dos **ossos salientes** do tornozelo (de fora ou de dentro), na **base do 5º metatarso** (meio da borda de fora do pé) ou no **navicular** (meio da borda de dentro do pé).

Numa revisão com mais de 15 mil pacientes, menos de 2% de quem não tinha nenhum desses sinais tinha fratura [2]. A regra é aplicada **no exame, por um profissional**: apertar o pé em casa não substitui a avaliação.

A torção mais comum

Na maioria das entorses, o pé **vira para dentro**. Os ligamentos do **lado de fora** do tornozelo, que são faixas firmes que seguram um osso ao outro, **estiram ou rompem**.

Os três graus

É a classificação tradicional usada no consultório. Os limites entre os graus não são exatos (opinião clínica).

- **Grau I (leve):** o ligamento estirou. Pouco inchaço; dá para andar com pouca dor.
- **Grau II (moderado):** ruptura parcial. Inchaço e mancha roxa; dor para andar.
- **Grau III (grave):** ruptura completa. Muito inchaço, dificuldade para apoiar e, às vezes, sensação de tornozelo "frouxo".

Por que o médico pode querer reexaminar em alguns dias

Nos primeiros dias, a dor e o inchaço atrapalham o exame. Num estudo, o exame físico repetido por volta do **5º dia** identificou 96 de cada 100 lesões de ligamento [3]. A diretriz holandesa recomenda esse exame tardio, entre o 4º e o 5º dia [4].

Não é "só uma torção"

O consenso internacional de especialistas em tornozelo trata a entorse como uma lesão que pode deixar consequências: dor que persiste, novas torções e tornozelo instável [5]. **Cuidar bem nas primeiras semanas faz diferença** (Página 9).

Em 2020, dois especialistas propuseram trocar o antigo "RICE" por **PEACE & LOVE** [6]. É uma proposta baseada em revisão da literatura e experiência, muito adotada, **e não um pacote testado em estudo**. O PEACE vale para os primeiros dias:

- **P — Proteger:** de 1 a 3 dias, diminua o que provoca dor forte. Proteger não é imobilizar por semanas.
- **E — Elevar:** pé acima do nível do coração quando estiver sentado ou deitado.
- **A — Evitar anti-inflamatórios:** os autores sugerem não "desligar" a inflamação no início. Veja abaixo.
- **C — Comprimir:** faixa elástica, firme sem apertar. Dedos frios, roxos ou dormentes: afrouxe.
- **E — Educar:** a recuperação leva semanas, e se mexer faz parte dela.

E o gelo?

Uma revisão de 11 estudos concluiu que **não há evidência suficiente** para dizer o quanto gelo, compressão e elevação ajudam na entorse [7]. O PEACE sugere evitar o gelo [6]. Se ele alivia a sua dor, uso curto, de 15 a 20 minutos e com pano entre o gelo e a pele, é razoável (opinião clínica).

E os remédios?

Este guia não indica remédio nem dose. Os estudos divergem: uma revisão encontrou evidência forte de alívio com anti-inflamatórios [8]; a diretriz holandesa diz que podem ser usados, mas têm complicações [4]; o PEACE sugere evitá-los [6]. A decisão é do seu médico.

Carga conforme a dor permite

Depois dos primeiros dias vem o **LOVE: carga** (do inglês *load*), **otimismo**, **vascularização** (atividade sem dor que faz o sangue circular) e **exercício** [6]. Numa revisão que reuniu dezenas de revisões, a **mobilização precoce** teve evidência forte [8]. Num estudo com 101 pessoas com entorse leve a moderada, começar exercícios já na primeira semana melhorou a função do tornozelo [9].

Órtese funcional, e não imobilização longa

A diretriz holandesa, atualizada em 2018, recomenda [4]:

- **Suporte funcional**, isto é, órtese ou bandagem que protege contra a torção e deixa caminhar, por **4 a 6 semanas**, junto com exercício.
- Se for preciso imobilizar por causa da dor e do inchaço: **no máximo 10 dias**, e depois tratamento funcional.

E na entorse grave?

Num estudo inglês com 584 pessoas com entorse grave, **10 dias** de bota gessada curta (abaixo do joelho) ou de órtese semirrígida levaram a uma recuperação **um pouco mais rápida** em 3 meses do que só uma faixa elástica tubular. A bota imobilizadora longa não teve vantagem. Houve casos raros de trombose [10].

Resumo honesto: a imobilização **curta** pode ter lugar na entorse grave. A imobilização **longa**, por conta própria, não. O tipo de suporte se decide na consulta.

A escolha destes três é opinião clínica. Cobrem mobilidade, força e equilíbrio, o que as diretrizes recomendam treinar [4][8]. Não substituem o fisioterapeuta.

Regra da dor (orientação prática): dor até 3, numa escala de 0 a 10, que volta ao seu normal até a manhã seguinte, é aceitável.

Exercício 1 — Alfabeto com o pé (mobilidade)

Como fazer: sentado ou deitado, com o pé elevado, "escreva" as letras do alfabeto no ar com o dedão, mexendo só o tornozelo. Uma ou duas vezes o alfabeto, 2 a 3 vezes ao dia.

Sensação correta: movimento um pouco duro, com incômodo leve.

Erro comum: mexer a perna inteira, ou forçar o pé para dentro, o mesmo movimento da torção.

Exercício 2 — Subir na ponta dos pés (força)

Como fazer: em pé, segurando numa bancada, suba devagar na ponta dos dois pés e desça contando 3 segundos. 2 a 3 séries de 10. Ficou fácil e sem dor? Faça só com o pé machucado.

Sensação correta: esforço na batata da perna.

Erro comum: jogar o peso todo no pé bom.

Exercício 3 — Equilíbrio numa perna só

Como fazer: ao lado de uma bancada, fique só sobre o pé machucado, até 30 segundos, de 3 a 5 vezes. Progrida: sem tocar na bancada; depois virando a cabeça ou de olhos fechados, sempre com apoio por perto.

Sensação correta: o tornozelo fazendo pequenos ajustes.

Erro comum: fechar os olhos ou usar superfície instável cedo demais.

Dias 1 a 3 — Proteger

- Elevação e compressão (Página 5).
- Apoie o pé no que a dor permitir; use muletas só se não conseguir andar.
- Exercício 1, 2 a 3 vezes ao dia.

Dias 4 a 7 — Carregar

- Caminhadas curtas, em terreno plano, aumentando aos poucos.
- Exercício 1 + Exercício 2 com os dois pés.
- Exercício 3, se conseguir ficar sobre o pé machucado sem dor forte.

Dias 8 a 14 — Progredir

- Exercício 2 com uma perna só e Exercício 3 sem apoio das mãos.
- Progrida **uma coisa de cada vez**.
- Esporte com corrida e mudança de direção: só depois de avaliação.

Os prazos e volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. A recuperação completa de uma entorse costuma levar mais que 2 semanas: siga a orientação da sua consulta.

Rastreador

	Dor parado (0–10)	Dor ao andar (0– 10)	Inchaço (menor / igual / maior)	Exercícios feitos (S/N)	Anda sem mancar? (S/N)
Dia 1					
Dia 2					
Dia 3					
Dia 5					
Dia 7					
Dia 10					
Dia 14					

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra a tendência, e não só o pior dia.

Depois de uma entorse, parte das pessoas fica com [5]:

- **novas torções**, às vezes com pouco esforço;
- sensação de tornozelo **frouxo**, que "falseia" em terreno irregular;
- **dor ou inchaço** que voltam com a atividade.

Quando isso persiste, o nome é **instabilidade crônica do tornozelo**.

O que reduz o risco de nova entorse

- **Treino de equilíbrio e controle do movimento:** evidência moderada [8]. Num estudo com 522 atletas que tinham torcido o tornozelo nos 2 meses anteriores, 8 semanas de treino em casa com prancha de equilíbrio, 3 vezes por semana, reduziram as novas entorses no ano seguinte: **22% contra 33%**. Foi cerca de 1 nova entorse evitada para cada 9 pessoas que treinaram [11].
- **Órtese** durante o esporte: evidência forte [8]. A diretriz holandesa recomenda considerá-la [4].

Nada disso é garantia: reduz o risco, mas não o zera.

E quando o tornozelo falseia mesmo assim?

O primeiro tratamento é **exercício bem feito e completo**. A cirurgia para reconstruir os ligamentos fica para quem **não melhora** com esse tratamento [4]. Nesse caso, a avaliação com um especialista em pé e tornozelo faz parte do cuidado.

1. Achar que é "só uma torção" e ignorar a Página 3.

Não conseguir dar 4 passos ou ter dor ao apertar o osso pede avaliação para radiografia [1][2].

2. Imobilizar por conta própria por semanas.

A diretriz limita a imobilização a, no máximo, 10 dias quando ela é necessária. Depois disso, o tratamento é funcional [4].

3. Parar os exercícios quando a dor passa.

Num estudo que acompanhou 82 pessoas depois da primeira entorse, dificuldades de equilíbrio e de aterrissar de um salto, nas semanas e meses seguintes, estavam entre os sinais ligados à instabilidade crônica 1 ano depois [12]. Sem dor não quer dizer recuperado (opinião clínica).

4. Voltar ao futebol ou à corrida antes de recuperar equilíbrio e força.

Mudança de direção exige um tornozelo que já responde bem (opinião clínica). Treino de equilíbrio e órtese reduzem nova entorse [8][11].

5. Exigir ressonância logo no primeiro dia.

O exame físico feito por volta do 5º dia identifica bem a lesão de ligamento [3]. O raio-X segue as Regras de Ottawa [1][2]. A ressonância fica para quando vai mudar a conduta (opinião clínica).

Bônus: gelo direto na pele ou faixa apertada demais.

Os dois podem machucar a pele ou prender a circulação.

Procure avaliação se:

- Você tem algum sinal das **Regras de Ottawa** (Página 3).
- O tornozelo inchou muito, ficou muito roxo ou parece **frouxo**: pode ser uma entorse grave, e o exame entre o 4º e o 5º dia ajuda a definir [3][4].
- A dor está **mais acima**, na canela, e piora ao girar o pé para fora. Pode ser a chamada "entorse alta", que tem outra evolução (opinião clínica).
- **Não há melhora clara em cerca de 2 semanas** de cuidado bem feito.
- O tornozelo **falseia** ou você já teve **várias entorses** (Página 9).
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal da Página 3.

O prazo de 2 semanas é bom senso clínico, não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: como foi a torção, os pontos de dor no osso, os ligamentos, o movimento, a força e o equilíbrio [13]. Radiografia quando as Regras de Ottawa indicam [1][2]; outros exames só quando vão mudar a conduta. Quando o caso pede um especialista em pé e tornozelo, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, Nair RC, et al. **Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Refinement and prospective validation.** JAMA. 1993;269(9):1127-1132. doi:10.1001/jama.269.9.1127. PMID: 8433468.
2. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, et al. **Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review.** BMJ. 2003;326(7386):417. doi:10.1136/bmj.326.7386.417. PMID: 12595378.
3. van Dijk CN, Lim LS, Bossuyt PM, Marti RK. **Physical examination is sufficient for the diagnosis of sprained ankles.** J Bone Joint Surg Br. 1996;78(6):958-962. doi:10.1302/0301-620x78b6.1283. PMID: 8951015.
4. Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, van der Doelen BFW, et al. **Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline.** Br J Sports Med. 2018;52(15):956. doi:10.1136/bjsports-2017-098106. PMID: 29514819.
5. Gribble PA, Bleakley CM, Caulfield BM, Docherty CL, et al. **2016 consensus statement of the International Ankle Consortium: prevalence, impact and long-term consequences of lateral ankle sprains.** Br J Sports Med. 2016;50(24):1493-1495. doi:10.1136/bjsports-2016-096188. PMID: 27259750.
6. Dubois B, Esculier JF. **Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE.** Br J Sports Med. 2020;54(2):72-73. doi:10.1136/bjsports-2019-101253. PMID: 31377722.
7. van den Bekerom MP, Struijs PA, Blankevoort L, Welling L, et al. **What is the evidence for rest, ice, compression, and elevation therapy in the treatment of ankle sprains in adults?** J Athl Train. 2012;47(4):435-443. doi:10.4085/1062-6050-47.4.14. PMID: 22889660.
8. Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. **Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis.** Br J Sports Med. 2017;51(2):113-125. doi:10.1136/bjsports-2016-096178. PMID: 28053200.
9. Bleakley CM, O'Connor SR, Tully MA, Rocke LG, et al. **Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial.** BMJ. 2010;340:c1964. doi:10.1136/bmj.c1964. PMID: 20457737.
10. Lamb SE, Marsh JL, Hutton JL, Nakash R, et al. **Mechanical supports for acute, severe ankle sprain: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial.** Lancet. 2009;373(9663):575-581. doi:10.1016/S0140-6736(09)60206-3. PMID: 19217992.
11. Hupperets MD, Verhagen EA, van Mechelen W. **Effect of unsupervised home based proprioceptive training on recurrences of ankle sprain: randomised controlled trial.** BMJ. 2009;339:b2684. doi:10.1136/bmj.b2684. PMID: 19589822.
12. Doherty C, Bleakley C, Hertel J, et al. **Recovery from a first-time lateral ankle sprain and the predictors of chronic ankle instability: a prospective cohort analysis.** Am J Sports Med. 2016;44(4):995-1003. doi:10.1177/0363546516628870. PMID: 26912285.
13. Delahunt E, Bleakley CM, Bossard DS, Caulfield BM, et al. **Clinical assessment of acute lateral ankle sprain injuries (ROAST): 2019 consensus statement and recommendations of the International Ankle Consortium.** Br J Sports Med. 2018;52(20):1304-1310. doi:10.1136/bjsports-2017-098885. PMID: 29886432.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765